

08 - 08- Présentation du Siège - Pr. SOUMMANI

Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule « La présentation du siège ». Qu'est-ce que c'est la présentation du siège ? C'est une présentation podalique, c'est-à-dire à l'inverse de la présentation du sommet où le fœtus se présente au détroit supérieur par son extrémité céphalique. Dans la présentation du siège, le fœtus se présente au détroit supérieur par le pôle podalique ou les fesses. C'est l'extrémité pelvienne du fœtus qui se met en premier au contact avec le détroit supérieur.

Cette présentation est une présentation eutossique. Ça veut dire que, généralement, l'accouchement se déroule normalement. Mais c'est une présentation eutossique à la limite de la dystossie.

Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, cette présentation qui était eutossique, cet accouchement qui était eutossique devient dystossique et peut engendrer des complications que ce soit maternelles ou fœtales. On l'appelle accouchement à rebrousse poil, c'est-à-dire au lieu que les poils vont vers l'arrière, ils vont vers le devant. Il faut savoir que toutes les présentations de sièges ne sont pas des indications de la césarienne et par conséquent, la césarienne n'est pas systématique.

Les objectifs de notre cours, d'abord la définition, les étiologies, comment faire le diagnostic au cours de la grossesse et au cours du travail, le mécanisme d'accouchement, les principales complications, les éléments obstétrico-pronostiques et la conduite obstétricale. Les étiologies, d'abord la fréquence, la fréquence de la présentation de sièges, c'est un peu 3% de tous les accouchements. La présentation de sièges est très fréquente chez le prématuré.

Pourquoi ? Parce que vous savez, dans le cours de la grossesse normale, qu'à partir de la 34e semaine, la tête de fœtus devient petite, le siège devient gros et par conséquent, selon la loi d'accommodation de Pajou, le petit extrémité va vers la partie la moins épaisse, c'est-à-dire au niveau du pelvis, alors que le siège va vers le fond de l'utérus. Dans les accouchements prématurés, c'est que le but physiologique, cette rotation physiologique n'a pas le temps de se faire et par conséquent, l'enfant va se présenter en siège. Pour les étiologies, il faut retenir que chaque cause qui peut bloquer la rotation physiologique au cours de 34e, 35e semaines de fœtus va constituer une cause.

Donc vous aurez des causes maternelles, soit congénitales, telles que l'hypoplasie utérine, les malformations utérines, les anomalies congénitales du bassin, mais également les causes acquises, les tumeurs de l'utérus telles que les fibromes, les tumeurs pelviennes telles qu'une tumeur ovarienne ou une tumeur osseuse, la multiparité. Dans ce cas, l'utérus est large, il est à borne et par conséquent, le fœtus va tourner comme il veut jusqu'à ce qu'il y ait la contraction utérine et il va se fixer dans cette présentation. La primiparité, ici l'utérus est hypertonique, donc il va se serrer contre le fœtus et le fœtus n'aura pas à faire sa rotation physiologique ou sa culbute.

physiologique.

Il y a également les anomalies acquises du bassin telles qu'une tumeur osseuse ou une fracture du bassin. Les causes ovulaires, il y a les anomalies du liquide amniotique, soit une augmentation du volume du liquide amniotique, l'hydramnios, où l'enfant va baigner dans le liquide amniotique, il va faire plusieurs rotations jusqu'à la survenue de la contraction utérine au début du travail, ou bien il y a une petite quantité de liquide amniotique qui ne va pas permettre au fœtus de tourner. Il y a la brièveté du cordon, un cordon ombilical court constitue une cause à la prématurité et les anomalies de l'insertion du placenta tel que le placenta va insérer.

Il y a les causes fœtales, la prématurité, les malformations fœtales telles que l'hydrocéphalie où le volume de la tête est très important, donc il est plus volumineux que l'extrémité pelvienne, il va se mettre en présentation du siège, et il y a les grossesses multiples. Comment faire le diagnostic de la présentation du siège ? Au cours de la grossesse, vous allez interroger la parturiente pour savoir ses antécédents, pour voir le déroulement de la grossesse actuelle, l'âge de la date de dernière règle pour voir l'âge de la grossesse. L'examen clinique à l'inspection, c'est un utérus qui est longitudinal, c'est-à-dire comme dans la présentation du sommet.

La palpation bimanuelle de l'abdomen, de l'utérus, va montrer une tête au niveau du fond de l'utérus. La tête est reconnue par sa dureté, c'est une extrémité qui est dure, qui est régulière et qui balote entre les mains. Et au niveau du détroit supérieur, au niveau du pelvis, vous allez trouver le siège qui est une partie qui est molle et qui est irrégulière.

Bon, vous allez chercher le plan du dos pour chercher ce qu'on appelle s'il y a une dépression du sillon du cou, en bas ou non, ici, bien sûr, parce qu'il y a un siège, on n'aura pas de sillon du cou. L'auscultation, vous allez chercher le foyer, au maximum il est en péri ou en sus ombilical, à l'inverse de la présentation du sommet où il est le plus souvent sous ombilical, donc vous allez ausculter les bruits du cœur fœtal. Le toucher vaginal, en général le col est fermé et l'excavation pelvienne évite, le siège n'est pas encore engagé.

Je dis que parfois vous faites tout ça et vous n'allez pas être sûr que c'est une présentation du siège, dans ce cas demandez soit une échographie pelvienne qui va vous permettre de visualiser l'extrémité céphalique en haut et le siège en bas, ou si vous n'avez pas les moyens de faire une échographie, vous pouvez demander une radio du contenu utérin, vous allez voir le squelette du bébé et dans ce cas vous allez savoir que c'est une présentation du siège. Le diagnostic de la présentation du siège au cours du travail, c'est-à-dire que la partie ruante présente déjà des contractions utérines, l'inspection et la palpation abdominales et l'auscultation ont les mêmes, vous aurez les mêmes informations qu'au cours de la grossesse, mais c'est surtout le toucher vaginal qui va donner plus de précision, surtout si la poche des os est rompue et vous avez accès à la présentation. Si la poche des os n'est pas rompue, il faut savoir la respecter, parce que la présentation, la poche des os va influencer la bonne dilatation du col de l'utérus.

Donc, le toucher vaginal au cours du travail va montrer une présentation qui est molle, il n'y a pas de suture, il n'y a pas de fontanelle, il va vous permettre de voir quel mode de présentation du siège. Il y a plusieurs modes. Les modes de présentation du siège sont de deux types.

Il y en a d'autres, mais les deux principaux types de sièges sont le siège décomplété, c'est-à-dire les deux membres inférieurs sont devant le tronc en extension. Donc, lorsque vous faites votre toucher, vous n'aurez pas accès aux pieds, vous n'aurez que deux masses molles, c'est les fesses et entre lesquelles il y a le sillon interfessier. Il y a dans le siège complet, où les membres sont en flexion, vous allez pouvoir, à côté des deux masses molles et du sillon, trouver des petits pieds.

Le repère de la présentation du siège est le sacro et qui va définir les variétés. Il y a la sacroilière gauche antérieure, la sacroilière droite antérieure, la sacroilière gauche postérieure et la sacroilière droite postérieure. Voilà sur cette photo les différents types de variétés de la présentation du siège.

Le mécanisme obstétrical. Le mécanisme obstétrical, vous aurez le temps de comprendre ce mécanisme, de bien comprendre au cours de votre passage dans le service de gynécologie obstétrique. Grosso modo, l'accouchement du siège se fait en trois temps.

D'abord l'accouchement du siège, après il y a l'accouchement des épaules et après il y a l'accouchement de la tête dernière. Ces trois temps, en général, sont intriqués. Ils ne se font pas successivement, mais ils se font de manière intriquée, c'est-à-dire qu'au même moment nous pouvons avoir ça.

Ce qui est important c'est que l'accouchement ne peut se faire que si le fœtus et tous les membres du fœtus, les extrémités sont collés les uns les autres, c'est-à-dire qu'un seul bloc où les temps sont confondus, il faut ce qu'on appelle une solidarisation de la tête en flexion du tronc et des membres. Si cette solidarisation fait défaut, on ne pourra pas avoir un accouchement eutocycle. D'abord, l'accouchement du siège, le premier temps.

Le diamètre qui va se présenter au détroit supérieur, c'est le diamètre bitrocanthérien qui mesure 95 mm et par conséquent il est favorable à l'accouchement. L'orientation de ce diamètre bitrocanthérien va se faire dans un des deux diamètres obliques du bassin, soit le droit soit le gauche. C'est pour ça qu'on parle de synchro iliaque droite antérieure ou gauche antérieure.

Une fois qu'il dépasse le détroit supérieur, il va faire sa rotation de telle sorte que le bitrocanthérien qui était oblique va devenir antéro-postérieur et la hanche antérieure va se caler sous la symphyse pubienne, la hanche postérieure va se dégager et le siège va monter jusqu'à ce que les deux hanches seront dehors. Et dans ce cas, vous devez obligatoirement avoir une rotation du dos en avant. Cette rotation du dos en avant est une condition sinéquanante à un accouchement autosique.

Une fois le siège est dehors, les épaules vont s'engager. En général, ils s'engagent dans le même diamètre oblique du détroit supérieur puisque le bitrocanthérien et le biacromial sont dans le même plan. Ils vont parcourir l'excavation et ils vont se dégager dans un diamètre transverse, d'abord l'épaule antérieure puis l'épaule postérieure.

L'accouchement de la tête dernière, j'ai dit bien qu'il faut une solidarisation de la tête au tronc. Donc la tête doit être solidaire des épaules. L'engagement va se faire dans le diamètre oblique qui est perpendiculaire à celui emprunté par le siège ou par les épaules.

Bien sûr, parce que le diamètre sous-occipitobrégmatique est perpendiculaire au diamètre biacromial et bitrocanthérien. Donc la tête va parcourir l'excavation. Il va faire une rotation de telle sorte que le sous-occiput, c'est-à-dire au-dessous de l'occiput, va se mettre derrière la symphyse pubienne et le montent s'applique sous le périnée et puis le dégagement va se faire.

De toutes les manières, j'ai cherché ce lien qui explique très bien comment se fait le mécanisme obstétrical de l'accouchement de siège. Voilà un peu, vous allez voir, si la femme est primée par une présentation de siège, il vaut mieux faire une épisiotomie. Ici, c'est une épisiotomie médiolatérale qu'on fait au service en général.

Et voilà la hanche antérieure qui est sous la symphyse pubienne qui va sortir en premier, puis la hanche postérieure qui va sortir. Voilà, ils sont en train de sortir. Voilà la rotation du dos en avant.

J'ai dit bien que cette rotation doit se faire obligatoirement. Si le fœtus tend à faire une rotation dos en arrière, il faut intervenir pour terminer l'accouchement. Voilà l'accouchement des épaules dans un diamètre transversal.

Voilà l'épaule antérieure, voilà l'épaule postérieure. Et voilà, ici c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Bracht, c'est-à-dire prendre le bébé et le mettre sur le ventre de sa maman pour accélérer la sortie de la tête. Voilà la tête qui sort.

Bon, cet accouchement, j'ai dit au début que l'accouchement du siège est un accouchement qui est eutoxique, mais à la limite de la dystocie. J'ai dit également qu'il faut qu'il y ait une solidarisation entre les différentes extrémités du fœtus, la tête, le tronc et les membres. Si au cours de l'accouchement, ces membres ne sont pas collés au tronc, ou si la tête fait une déflexion, ou bien si le dos ne tourne pas en avant, tout ça va entraîner ce qu'on appelle des accidents obstétricaux au niveau de l'accouchement du siège, et vous aurez des complications.

Parmi les complications, c'est la mortalité qui est très élevée, entre 0,71 et 3,70 %. Cette mortalité peut être due à l'asphyxie du postpartum, des malformations sévères, parce que j'ai dit qu'il y a des malformations fœtales qui peuvent associer à la présentation du siège, la mort fœtale in utero et les traumatismes obstétricaux. La morbidité, les complications immédiates, c'est surtout des déformations plastiques du fœtus. Il faut savoir qu'à part la plâtrie du crâne, le reste peut disparaître après.

Donc il y a la dolicocephalie, il y a la plasie du maxillaire, il y a les torticolis congénitaux, la plasie du cou qui va entraîner la luxation congénitale de l'angle, et les pieds varus ou valgus. Donc, comme tout accouchement, le bébé doit être vu par le pédiatre et après, s'il y a des anomalies telles que la plasie du cou, telles que le pied bot ou les pieds valgus ou varus, vous demandez l'avis du chirurgien-pédiatre-traumatologue. Il y a également des lésions neurologiques, soit l'hémorragie cérébrale ou méningée très fréquente au cours de l'accouchement du siège, soit, vu qu'un obstétricien mal expérimenté qui tire trop sur le bébé et qui entraîne une lésion du plexus brachial.

Il y a également les fractures, les lésions musculaires, et bien sûr, puisque le fœtus se présente par son extrémité pelvienne, il y a le risque de lésions de l'appareil génital, surtout chez le sexe masculin. À long terme, il n'y a pas beaucoup de différences entre un enfant né par le siège et un enfant né par le sommet, bien que vous allez trouver dans quelques bouquins qu'il y a un retard scolaire, des troubles de la mémoire, de lecture, de langage, mais en général, si ce n'est pas la prématurité ou s'il n'y a pas d'accident de traumatisme obstétrical, vous n'aurez pas ces complications. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez une présentation de siège ? D'abord, il faut faire un bilan obstétrical.

Ce bilan obstétrical, qui se fait au troisième trimestre de la grossesse, va montrer quelques facteurs de risque du siège. Les facteurs photo, en général, le siège décomplété est de bon pronostic que le siège complet. L'âge gestationnel, la prématurité, ou bien le retard de croissance intra-utérin, l'hypotrophie, constituent également un facteur de risque.

La biométrie fœtale, un enfant de plus de 4 kg, une estimation de poids fœtal de plus de 4 kg, est un facteur de mauvais pronostic. Et la position de la tête fœtale. Une tête fœtale en intra-utérin, en déflexion, et ce qu'on appelle la déflexion primitive de la tête dernière, est une indication formelle à la césarienne.

Les facteurs maternels, il y a l'âge, il y a la parité, le poids, la femme obèse, la taille, une femme de petite taille, sont des facteurs défavorables à l'accouchement. La qualité du bassin, il faut que le bassin soit normal, et la qualité de l'utérus également. Les facteurs fœto-maternels, surtout la souffrance fœtale chronique, ou l'infertilité.

Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, la césarienne prophylactique. Qu'est-ce que ça veut dire la césarienne prophylactique ? C'est une césarienne qui est programmée, qui se fait à la 39e semaine d'aménorrhée. C'est une césarienne qui se fait le matin, la femme doit être à jeûne, elle doit être vue préalablement par un anesthésiste réanimateur, éventuellement un bilan biologique est demandé avant.

C'est une femme qui devrait être opérée par une équipe qui n'est pas de garde, parce que l'équipe de garde en général est épuisée, et éventuellement on peut avoir des complications. Les indications formelles à cette césarienne prophylactique en matière de présentation du siège, c'est

les anomalies du bassin, on ne peut accepter que les patientes qui ont un bassin normal pour l'accouchement, sinon c'est une césarienne. La déflexion primitive de la tête dernière, c'est une parce qu'il y a un risque très important de lésions médulaires, et par conséquent il faut faire la césarienne.

Le placenta previa, c'est une indication, et le périnée cicatriciel, parce qu'il y a le risque de faire des manœuvres et entraîner un éclatement du périnée. Les indications relatives, on peut discuter au staff obstétrique, c'est l'utérus cicatriciel, la grande prématurité, la souffrance fœtale chronique, la primé parité âgée, les antécédents d'infertilité et les antécédents de dysplasie. Il y a une indication à la version par manœuvre externe, c'est-à-dire tenter au 36e semaine de faire que l'obstétricien fait lui-même la rotation, et il y a beaucoup de risques sans qu'il y ait un bénéfice net.

Au cours du travail, la femme, on a dit qu'il n'y a pas de facteur de risque, la femme peut accoucher normalement, on va la laisser entrer spontanément au travail. La phase de dilatation, en général, il se fait de façon harmonieuse, on dit toujours à bonne dilatation, bon siège, c'est-à-dire si la dilatation est harmonieuse, si la dilatation est bonne, l'accouchement va se faire de manière correcte. Si la poche des os n'est pas rompue, il faut la respecter.

S'il y a une hypokinésie, vous pouvez donner une perfusion de cytotocycle. Vous pouvez également faire une péridurale. Au cours de l'expulsion, il faut remplir la poche des os, c'est-à-dire la phase d'expulsion, c'est-à-dire la dilatation est complète.

Et c'est le moment où la femme va accoucher. Donc, rompre la poche des os s'il n'est pas toujours rompue, perfuser des autres cytotocycles s'il ne l'était pas, et surveiller la dilatation, surtout l'engagement et le rythme cardiaque fœtal. La phase d'expulsion, en général, va durer 30 minutes, on peut aller jusqu'à 45 ou même jusqu'à une heure, en fonction des conditions obstétricales.

S'il n'y a pas de souffrance, le liquide est clair, s'il n'y a pas de risque, vous pouvez attendre jusqu'à une heure. Il faut faire une épisiotomie pour protéger le périnée, surtout chez la primipare. En cas de complication, c'est-à-dire relèvement des bras, déflexion de la tête dernière, tentative de rotation de dos en arrière, vous devez intervenir pour faire des manœuvres.

Dans le relèvement des bras, on fait la manœuvre de l'offset, dans la rétention de la tête dernière, c'est la manœuvre de Brasch ou de Morisseau, et d'autres manœuvres peuvent se faire, la petite extraction du siège ou la grande extraction du siège. La grande extraction du siège, en général, est réservée dans l'accouchement gemellaire du deuxième jumeau en présentation du siège.